avitaserena.

GUIDE GRATUIT

SIBO : comprendre les bases.

Ce qui se passe dans votre intestin grêle, pourquoi les symptômes ne suffisent pas à conclure, et par où commencer.

Sabrina Castelli · Praticienne en naturopathie
Santé digestive et hormonale des femmes · Porto-Vecchio, Corse
avitaserena.com

AVANT DE COMMENCER

Ce que ce guide est, et ce qu'il n'est pas.

Un guide pour comprendre ce qui se passe dans votre ventre, avant de chercher à agir.

Vous avez peut-être des ballonnements, un transit imprévisible, une fatigue que rien n'explique. Ce guide vous donne les bases pour comprendre le SIBO : ce que c'est, pourquoi les symptômes ne suffisent pas à conclure, pourquoi cela survient, et quelles erreurs retardent souvent les choses.

Il explique le **pourquoi** avant le **comment**. C'est volontaire : quand on comprend un mécanisme, on pose de meilleures questions à son médecin et on évite de s'enfermer dans des solutions qui ne correspondent pas à sa situation.

> **CE GUIDE NE POSE PAS DE DIAGNOSTIC**
>
> Il est éducatif. Il ne remplace ni une consultation médicale, ni un examen, ni un traitement. Seul un professionnel de santé peut poser un diagnostic.

CONSULTEZ SANS ATTENDRE SI VOUS AVEZ

- un amaigrissement que vous n'expliquez pas ;
- du sang dans les selles, ou des selles noires ;
- une anémie découverte à une prise de sang ;
- de la fièvre, des vomissements répétés, ou une difficulté à avaler ;
- des douleurs qui vous réveillent la nuit ;

- des symptômes digestifs nouveaux après 50 ans, ou des antécédents familiaux de cancer colorectal, de maladie cœliaque ou de maladie de Crohn.

Ces signes demandent un avis médical rapide. Ils ne relèvent pas d'un guide.

CHAPITRE 1

Ce qu'est vraiment le SIBO.

Trop de bactéries, au mauvais endroit.

SIBO signifie **Small Intestinal Bacterial Overgrowth**, soit une pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Cette partie de l'intestin mesure environ six mètres. C'est là que vous absorbez l'essentiel de ce que vous mangez. Elle contient normalement peu de bactéries. C'est le côlon, plus loin, qui en héberge la grande majorité, et c'est normal.

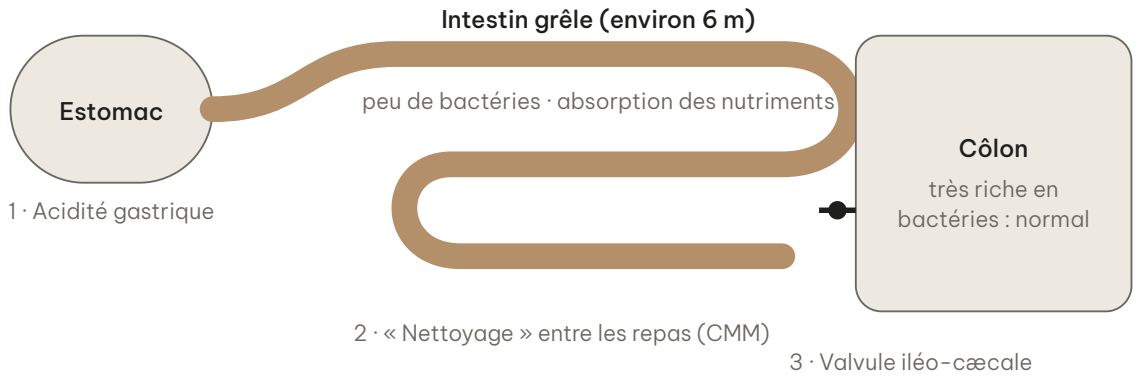


Schéma simplifié. Trois protections limitent le nombre de bactéries dans l'intestin grêle : l'acidité de l'estomac, le « nettoyage » entre les repas et la valvule qui sépare l'intestin grêle du côlon.

Pourquoi cela donne des symptômes

Les bactéries se nourrissent des glucides que vous mangez. Si elles sont trop nombreuses dans l'intestin grêle, elles en fermentent une partie avant que vous ayez pu l'absorber. Cette fermentation produit des gaz : de l'hydrogène, du méthane ou, plus rarement identifié, du sulfure d'hydrogène.

L'intestin grêle est étroit et très riche en terminaisons nerveuses. Quelques gaz de plus y suffisent à provoquer un ventre tendu, des douleurs, des nausées ou un changement de transit. Selon les gaz produits, le transit peut s'accélérer ou ralentir.

> **POURQUOI ON PARLE DE CONSÉQUENCE**
>
> Le SIBO est le plus souvent **la conséquence** d'une protection affaiblie, pas une cause isolée. Les bactéries n'envahissent pas un intestin en bonne santé : quelque chose a relâché les défenses. C'est pour cela que traiter uniquement les bactéries, sans comprendre ce qui a relâché ces défenses, expose aux rechutes (chapitre 5).

CHAPITRE 2

Les signes, et pourquoi ils ne suffisent pas.

Les mêmes symptômes se retrouvent dans plusieurs situations.

CE QUE L'ON DÉCRIT	POURQUOI CELA PEUT SE PRODUIRE
Ventre gonflé après les repas, surtout en fin de journée	La fermentation s'accumule au fil des repas. Plus la journée avance, plus les gaz s'accumulent.
Transit accéléré, ralenti ou irrégulier	Certains gaz accélèrent le transit, d'autres le ralentissent. C'est pourquoi on peut avoir de la diarrhée, de la constipation, ou les deux.
Douleurs ou crampes basses	Les gaz distendent une zone étroite et sensible.
Fatigue, brouillard mental	Ces signes ont de nombreuses causes possibles (sommeil, carences, thyroïde, stress). Leur lien avec un SIBO reste incertain. Ils ne doivent jamais être interprétés seuls.
Reflux, nausées	Ils sont fréquents dans beaucoup de troubles digestifs, et ne désignent aucune cause en particulier.

POURQUOI LES SYMPTÔMES NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE

Ces signes passent par les mêmes mécanismes dans le SIBO, le syndrome de l'intestin irritable, certaines intolérances (comme celle au lactose), la maladie cœliaque ou un trouble thyroïdien. Les symptômes ne permettent donc **ni de confirmer un SIBO, ni d'en déterminer le type**. Seuls des examens, interprétés avec votre histoire, y contribuent.

SIBO ou intestin irritable ?

Le syndrome de l'intestin irritable (SII) est un diagnostic fondé sur des symptômes, posé après avoir écarté d'autres maladies. Le SIBO, lui, est un excès de bactéries que l'on cherche à mesurer. Les deux se recoupent : dans certaines analyses, jusqu'à 78 % des personnes ayant un SII auraient un SIBO,

mais ce chiffre varie beaucoup selon les études et les tests utilisés. Les spécialistes discutent encore pour savoir si le SIBO est une cause du SII, une conséquence, ou les deux.

Ce que l'on peut retenir : un diagnostic de SII n'exclut pas la possibilité d'un SIBO, et deux personnes aux symptômes identiques peuvent avoir des terrains très différents.

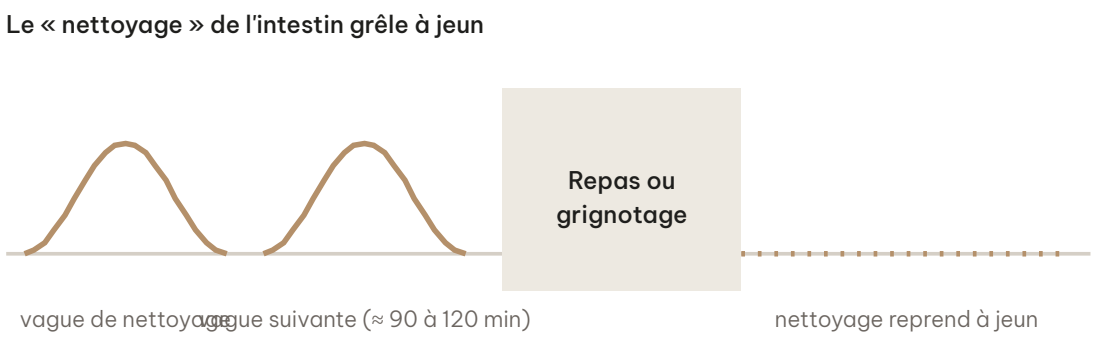
CHAPITRE 3

Pourquoi cela arrive.

Il y a presque toujours un « premier domino ».

L'intestin grêle se protège de trois façons. Quand l'une d'elles faiblit, les bactéries peuvent s'y installer en excès.

- **L'acidité de l'estomac** élimine une grande partie des bactéries avalées avec les aliments. Si elle diminue, davantage de bactéries survivent.
- **Le « nettoyage » entre les repas**, appelé complexe moteur migrant : à jeun, une vague de contractions balaie l'intestin grêle environ toutes les 90 à 120 minutes et fait avancer son contenu, bactéries comprises.
- **La valvule iléo-cæcale**, qui sépare l'intestin grêle du côlon et limite la remontée de son contenu.



Chaque repas ou grignotage interrompt la vague de nettoyage. Elle ne reprend qu'après une période à jeun.

Ce qui peut faire faiblir ces protections

Les recommandations médicales citent notamment : certains médicaments (les inhibiteurs de la pompe à protons, les opioïdes, certains traitements qui ralentissent le transit), une chirurgie abdominale ou des adhérences, des troubles de la motilité comme ceux liés au diabète, une faible acidité gastrique, des maladies digestives comme la maladie cœliaque ou la maladie de Crohn, l'avancée en âge, et le sexe féminin. Le lien avec les inhibiteurs de la pompe à protons est qualifié de « complexe » : toutes les études ne le retrouvent pas.

D'autres pistes sont explorées, avec des niveaux de preuve variables : une infection digestive sévère dans le passé, un trouble thyroïdien, le stress chronique qui perturbe le système nerveux de l'intestin. Elles méritent d'être posées en consultation, sans être présentées comme des certitudes.

POURQUOI CHERCHER LE PREMIER DOMINO

Dans une étude suivant 80 adultes traités par antibiotiques, le SIBO était revenu chez environ 44 % d'entre eux au bout de 9 mois. Si la

> cause n'est pas identifiée, les mêmes conditions favorisent le retour des bactéries.

CHAPITRE 4

Cinq erreurs qui retardent tout.

Elles ne sont pas des fautes : on les fait souvent en suivant des conseils bien intentionnés.

ERREUR 1 · CONCLURE À PARTIR DES SYMPTÔMES

Penser « j'ai un SIBO » parce que les symptômes ressemblent, ou à l'inverse écarter l'idée. **Pourquoi c'est un piège :** les mêmes signes existent dans d'autres situations (chapitre 2), et un test respiratoire mal préparé peut donner un faux résultat.

ERREUR 2 · S'ENFERMER DANS UNE ALIMENTATION DE PLUS EN PLUS RESTRICTIVE

Retirer des aliments soulage souvent, parce que moins de fermentation signifie moins de gaz. **Pourquoi ce n'est pas une solution :** cela réduit les symptômes, pas la cause. Les recommandations médicales indiquent que les preuves en faveur des régimes de type pauvre en FODMAP dans le SIBO sont de très faible qualité. Une restriction longue peut aussi appauvrir l'alimentation et entretenir la peur de manger.

> **PRUDENCE : ANTÉCÉDENTS DE TROUBLES ALIMENTAIRES**
>
> Si vous avez déjà eu un trouble du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, restriction, orthorexie), ou si vous vous sentez à risque, **ne vous lancez pas seul·e dans un régime restrictif**. Parlez-en d'abord à votre médecin ou à un professionnel formé à ces situations.

> Une période de restriction peut réveiller de vieux schémas, même avec de bonnes intentions.

ERREUR 3 · MANGER EN CONTINU TOUTE LA JOURNÉE

Même sainement. **Pourquoi :** chaque prise alimentaire interrompt la vague de nettoyage de l'intestin grêle (chapitre 3). Laisser des intervalles sans manger entre les repas lui permet de faire son travail. Les preuves cliniques sont modestes, mais le raisonnement physiologique est solide. Cela ne convient pas à tout le monde (diabète sous traitement, grossesse, poids bas, antécédents de troubles alimentaires) : demandez conseil dans ces cas.

ERREUR 4 · EMPILER DES PRODUITS SANS MÉTHODE

Ajouter plusieurs compléments ou probiotiques à la fois, sur les conseils de forums ou de réseaux sociaux. **Pourquoi c'est risqué :** les recommandations médicales indiquent qu'il n'existe pas de données cohérentes pour recommander des probiotiques précis dans le SIBO, et des effets indésirables ont été rapportés. En ajoutant tout en même temps, on ne sait plus ce qui aide ou ce qui aggrave. Un produit n'est ni toujours utile, ni toujours dangereux : cela dépend de votre situation et de vos traitements en cours.

ERREUR 5 · TRAITER SANS CHERCHER POURQUOI

Éliminer les bactéries sans comprendre ce qui a favorisé leur retour. **Pourquoi :** comme vu au chapitre 3, tant que le premier domino n'est pas identifié, la rechute est fréquente.

CHAPITRE 5

Un questionnaire d'observation.

Pas un test : une façon de mettre de l'ordre dans ce que vous vivez.

Cochez ce qui vous correspond. Il n'y a pas de score ni de résultat : ce questionnaire ne dit pas si vous avez un SIBO, parce que seuls des examens et un avis médical peuvent le faire. Il sert à préparer une discussion plus précise avec votre médecin ou avec moi.

VOS SYMPTÔMES

- ☐ Je suis gonflé·e presque chaque jour, surtout après les repas ou en fin de journée.
- ☐ Mon transit est irrégulier : constipation, diarrhée, ou alternance.
- ☐ J'ai des douleurs ou des crampes dans le bas du ventre.
- ☐ Je ressens des reflux ou des nausées en plus de mes troubles digestifs.
- ☐ Mes symptômes changent selon ce que je mange, sans que je comprenne pourquoi.

VOTRE HISTOIRE

- ☐ Mes troubles ont débuté ou se sont aggravés après une infection digestive, un traitement antibiotique ou une opération du ventre.
- ☐ J'ai pris un traitement contre l'acidité de l'estomac pendant longtemps.
- ☐ J'ai un diabète, un trouble thyroïdien, ou un trouble hormonal (SOPK, endométriose, périménopause).
- ☐ On m'a parlé d'intestin irritable sans proposer d'examen complémentaire.
- ☐ J'ai déjà essayé plusieurs régimes ou compléments sans résultat durable.

SI VOUS AVEZ COCHÉ PLUSIEURS CASES

C'est un bon motif pour en parler à votre médecin ou à un gastro-entérologue, qui pourra décider d'un test. Vous pouvez aussi faire le **questionnaire en ligne** sur avitaserena.com/quiz-sibo, qui oriente sans diagnostiquer. Et si l'un des signes d'alerte de la première page vous concerne, consultez avant tout.

ET MAINTENANT

Comprendre pour avancer.

Vous avez les bases. La suite dépend de ce que vous cherchez :

- **Comprendre en détail** : le guide complet, **SIBO : comprendre, tester, agir**, explique le test respiratoire pas à pas, les trois profils de gaz, le lien avec vos hormones, la logique d'un accompagnement et la manière de préparer vos rendez-vous. Il contient aussi des fiches imprimables. **22 €** · avitaserena.com/ebook-sibo
- **Être orientée** : le questionnaire en ligne, gratuit, sur avitaserena.com/quiz-sibo.
- **Faire le point sur votre histoire** : le bilan de vitalité dure 90 minutes en visio. Il relie vos symptômes, votre parcours médical et votre terrain hormonal, en lien avec votre suivi médical. Réservation sur avitaserena.com/reservation.

avitaserena.

© 2026 A VITA SERENA · Sabrina Castelli · avitaserena.com · sabrina@avitaserena.com
Ce guide a un objectif éducatif. Il ne constitue ni un diagnostic médical, ni un traitement, et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.